Estilo UERJ

Simulado 9 Caderno

Prova inédita no formato da UERJ: quatro alternativas, casos longos e a armadilha da banca em cada questão.

50 questões

17 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 50 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 2 horas e 30 minutos, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Mulher de 45 anos tem diabetes tipo 1 há 26 anos, com retinopatia tratada com laser, neuropatia periférica e hipotensão postural leve. Usa glargina e insulina asparte nas refeições. Até 4 meses atrás não tinha sintomas digestivos. Por obesidade (IMC 32 kg/m²), outro médico iniciou semaglutida subcutânea há 4 meses, hoje em 1 mg por semana. Há 3 meses tem saciedade precoce, plenitude, náuseas e vômitos de alimentos ingeridos muitas horas antes; perdeu 9 kg. Passou a ter hipoglicemias cerca de 1 hora após o bolus das refeições e hiperglicemias no fim da tarde. Endoscopia: restos alimentares no estômago, sem obstrução nem úlcera. Sódio, potássio e cortisol matinal normais; anticorpo antitransglutaminase negativo. A causa mais provável do quadro digestivo é:

A) Gastroparesia diabética autonômica

B) Insuficiência adrenal autoimune

C) Doença celíaca associada

D) Esvaziamento retardado pela semaglutida

---

2 Homem de 35 anos, pedreiro em Belo Horizonte, foi picado há 40 minutos no dedo indicador direito por escorpião amarelo, que trouxe morto ao PS. Refere dor intensa, em queimação, irradiada ao antebraço, com parestesia local. Exame: lúcido, ansioso pela dor, sudorese e piloereção restritas à mão, FC 92 bpm, PA 132 × 84 mmHg, FR 18 irpm, sem vômitos, sem sialorreia, sem agitação psicomotora, ausculta pulmonar normal. A conduta mais adequada é:

A) Bloqueio anestésico local e observação

B) Soro antiescorpiônico, 3 ampolas

C) Soro antiaracnídico, 5 ampolas

D) Soro antiescorpiônico, 6 ampolas

---

3 Homem de 49 anos, IMC 44 kg/m², hipertenso, é encaminhado por sonolência diurna, ronco alto e cefaleia matinal. Está estável e nunca foi internado. Gasometria arterial em ar ambiente, acordado: pH 7,38, PaCO2 51 mmHg, PaO2 66 mmHg, HCO3 30 mEq/L. Espirometria: CVF 82% do previsto, VEF1/CVF 0,80. Radiografia de tórax e ecocardiograma sem alterações relevantes; TSH normal. Polissonografia: índice de apneia e hipopneia de 58 eventos por hora, com SpO2 mínima de 74%. Além de encaminhar para perda de peso, o tratamento ventilatório inicial mais adequado é:

A) CPAP noturno

B) BiPAP com frequência de resgate

C) Oxigênio noturno isolado

D) Traqueostomia

---

4 No receptor de transplante renal cuja doença de base é a síndrome de Alport ligada ao X, a complicação imunológica específica dessa doença de base, a ser vigiada no enxerto, é:

A) Nefropatia pelo poliomavírus BK

B) Recidiva da nefropatia hereditária

C) Doença anti-membrana basal glomerular

D) Glomeruloesclerose segmentar recorrente

---

5 Homem de 29 anos tem o terceiro episódio de trombose venosa profunda proximal em quatro anos, todos sem fator provocador, e dois tios maternos tiveram trombose antes dos 40 anos. Internado com trombose iliofemoral extensa, iniciou heparina não fracionada em bomba, com ajustes sucessivos: mesmo chegando a doses muito acima do habitual por peso, o TTPa permanece subterapêutico e o anti-Xa dosado está baixo para a dose infundida. Plaquetas 243.000/mm³, TP normal, função hepática e renal normais, sem perda proteica urinária, sem uso prévio de heparina. A causa mais provável da resposta inadequada à heparina é:

A) Deficiência de proteína C

B) Deficiência de antitrombina

C) Mutação do gene da protrombina

D) Fator V de Leiden

---

6 Homem de 26 anos, com retocolite ulcerativa extensa há 3 anos, teve há 5 meses o primeiro episódio de pancreatite aguda leve, quando usava mesalazina; a droga foi suspensa e trocada por azatioprina, que também foi suspensa há 4 meses por intolerância. Hoje está apenas com vedolizumabe e tem o segundo episódio de dor epigástrica com lipase de 1.400 U/L. Não consome álcool; triglicerídeos 140 mg/dL, cálcio normal, ultrassonografia sem cálculos ou lama. Ressonância: pâncreas difusamente aumentado, com perda das lobulações, halo hipointenso periférico e ducto principal afilado e irregular, sem dilatação a montante, sem massa; vias biliares, rins e glândulas salivares normais. IgG4 sérica de 52 mg/dL (referência até 135). O diagnóstico mais provável é:

A) Pancreatite autoimune tipo 2

B) Pancreatite autoimune tipo 1

C) Pancreatite induzida por mesalazina

D) Adenocarcinoma de pâncreas

---

7 Mulher de 31 anos, com artrite reumatoide em remissão com leflunomida 20 mg/dia e hidroxicloroquina 400 mg/dia há 2 anos, descobre gestação de 6 semanas, não planejada; usava anticoncepcional oral de forma irregular. Está sem sinovite, com DAS28 de 2,1, e deseja manter a gestação. Em relação à leflunomida e à hidroxicloroquina, a conduta é, respectivamente:

A) Suspender apenas / suspender

B) Suspender com colestiramina / suspender

C) Suspender com colestiramina / manter

D) Suspender apenas / manter

---

8 Mulher de 35 anos, com esclerose múltipla remitente-recorrente, usa natalizumabe IV a cada 4 semanas há 30 meses, sem surtos e com RM estável há 2 anos; ela gosta da droga e quer mantê-la. Antes dele, usou mitoxantrona por 1 ano. O índice de anticorpos anti-vírus JC, que era 0,3 há 18 meses, agora é de 1,9. EDSS 2,0, sem queixas novas. A RM de controle de hoje não mostra lesões novas. A conduta mais adequada é:

A) Manter natalizumabe e repetir RM em 12 meses

B) Trocar por anticorpo monoclonal anti-CD20

C) Manter natalizumabe com pulsos mensais de corticoide

D) Suspender natalizumabe sem nova terapia

---

9 Homem de 58 anos, com prótese mecânica mitral há 9 anos por estenose mitral reumática, em uso de varfarina, suspendeu o anticoagulante por conta própria há 3 semanas para uma extração dentária e não o reiniciou. Há 2 dias tem dispneia progressiva, hoje em repouso. Exame: PA 84×56 mmHg, FC 122 bpm, ritmo irregular, SpO2 86% com máscara, crepitações até os ápices, extremidades frias e cliques protéticos abafados. INR 1,1. Ecocardiograma transesofágico: um dos discos imóvel, gradiente médio transprotético de 19 mmHg e trombo de 1,4 cm² aderido à prótese; a fluoroscopia confirma a restrição. O hospital tem cirurgia cardíaca disponível, e o risco cirúrgico estimado é intermediário (EuroSCORE II de 4%). A conduta mais adequada é:

A) Fibrinólise com alteplase

B) Troca valvar de emergência

C) Heparina intravenosa e reavaliar

D) Varfarina com alvo de INR maior

---

10 Homem de 38 anos, com HIV em TARV regular (CD4 520 células/mm³, carga viral indetectável), procura oftalmologista por embaçamento visual e moscas volantes no olho esquerdo há 2 semanas. Exame oftalmológico: acuidade 20/80, vitreíte e placa amarelada placoide em polo posterior. Sem cefaleia, sem rigidez de nuca, exame neurológico normal. VDRL sérico 1:128 e teste treponêmico reagente; há 8 meses, o VDRL era não reagente. Líquor: 3 células/mm³, proteína 38 mg/dL, glicose 60 mg/dL, VDRL não reagente. O tratamento mais adequado é:

A) Penicilina benzatina, 3 doses semanais

B) Penicilina cristalina IV por 14 dias

C) Doxiciclina oral por 28 dias

D) Penicilina benzatina em dose única

---

11 Homem de 49 anos tem acromegalia por macroadenoma operado há 2 anos, com resíduo tumoral no seio cavernoso. Usou octreotida de liberação prolongada em dose máxima por 1 ano sem normalizar o IGF-1 e, há 6 meses, passou a usar pegvisomanto em monoterapia. Refere melhora da sudorese, da cefaleia e das parestesias. Glicemia de jejum caiu de 162 para 108 mg/dL. Exames atuais: IGF-1 de 1,0 vez o limite superior para a idade (antes, 2,4 vezes), GH sérico 14 ng/mL (antes do pegvisomanto, 6 ng/mL), AST e ALT normais. Ressonância de sela há 1 mês: resíduo de 8 mm, sem mudança em relação ao exame de 1 ano antes. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Nova cirurgia transesfenoidal

B) Manter o esquema e seguir pelo IGF-1

C) Radioterapia estereotáxica do resíduo

D) Aumentar a dose do pegvisomanto

---

12 Homem de 44 anos, tabagista, tem dispneia progressiva aos esforços há 10 meses, com tosse pouco produtiva; nega febre e perda de peso. Recebeu dois ciclos de antibiótico por pneumonia que não resolve. Anti-HIV negativo, sem uso de imunossupressores. SpO2 91% em repouso, poucos estertores, sem baqueteamento. DLCO 48%. TC: vidro fosco bilateral de distribuição geográfica, com espessamento de septos sobreposto (pavimentação em mosaico), poupando áreas subpleurais. Lavado broncoalveolar: aspecto leitoso, macrófagos espumosos e material acelular PAS positivo; imunofluorescência para Pneumocystis negativa; sem predomínio de eosinófilos e sem hemossiderófagos. O diagnóstico mais provável é:

A) Pneumocistose

B) Pneumonia eosinofílica crônica

C) Hemorragia alveolar difusa

D) Proteinose alveolar pulmonar

---

13 Homem de 38 anos, em pré-operatório de herniorrafia inguinal, nega sangramento anormal, inclusive em extração dentária e amigdalectomia na infância, e nega uso de medicamentos. Não há história familiar de sangramento. Exame físico normal, sem petéquias ou equimoses. Exames: plaquetas 228.000/mm³, TP com INR 1,0, TTPa 58 segundos (VR 25 a 35), tempo de trombina normal, fibrinogênio 310 mg/dL. O teste da mistura com plasma normal, a 1:1, imediato e após 2 horas de incubação a 37 °C, mostrou TTPa de 52 segundos, ou seja, não corrige. O próximo exame mais adequado é:

A) Teste do veneno de víbora de Russell diluído

B) Dosagem de fator VIII e título de inibidor

C) Dosagem de fator XII

D) Dosagem de fator XI

---

14 Na primeira sessão de hemodiálise de um paciente com doença renal crônica avançada, não dialítica até então, com ureia de 320 mg/dL, para prevenir a complicação neurológica mais temida desta sessão, ela deve ter, quanto à duração e ao fluxo de sangue, respectivamente:

A) Longa, cerca de 4 horas / alto

B) Longa, cerca de 4 horas / baixo

C) Curta, cerca de 2 horas / alto

D) Curta, cerca de 2 horas / baixo

---

15 Mulher de 63 anos, tabagista de 40 anos-maço, tem há 10 semanas formigamento e dormência que começaram na mão direita e se estenderam aos quatro membros e à face, de forma assimétrica, com piora da marcha no escuro. Exame: força preservada, arreflexia global, perda de propriocepção nas mãos com pseudoatetose, Romberg presente. Eletroneuromiografia: potenciais de ação sensitivos ausentes difusamente, com condução motora normal. Líquor com proteína de 62 mg/dL e 4 células/mm³. Anticorpo anti-Hu fortemente positivo no soro. Glicemia, vitamina B12 e eletroforese de proteínas normais; anti-Ro e anti-La negativos. A TC de tórax com contraste não mostra nódulos, massas ou linfonodomegalias. O próximo exame mais adequado é:

A) Nova TC de tórax em 6 meses

B) Broncoscopia com lavado broncoalveolar

C) Ressonância magnética das mamas

D) PET-CT com FDG de corpo inteiro

---

16 Homem de 33 anos tem espondilite anquilosante há 3 anos, com HLA-B27 positivo e sacroiliíte bilateral na ressonância. Usou naproxeno 500 mg duas vezes ao dia por 6 semanas e depois celecoxibe 200 mg duas vezes ao dia por 6 semanas, sem melhora: BASDAI de 6,2 e PCR de 24 mg/L. Teve três episódios de uveíte anterior aguda no último ano, tratados com colírio de corticoide. Tem placas de psoríase em cotovelos e couro cabeludo, menos de 3% da superfície corporal. Sem doença inflamatória intestinal, insuficiência cardíaca ou doença desmielinizante; IGRA negativo. O tratamento mais adequado é:

A) Adalimumabe

B) Secuquinumabe

C) Etanercepte

D) Sulfassalazina

---

17 Mulher de 31 anos procura o ambulatório por crises de dor em choque na bochecha e no lábio superior direitos há 2 meses, de 1 a 2 segundos, dezenas por dia, desencadeadas por escovar os dentes, mastigar e vento no rosto, com períodos refratários; entre as crises não tem dor. Antes das crises fez tratamento de canal num pré-molar superior direito, sem alívio. Nega outros sintomas. PA 118/74 mmHg. Exame: hipoestesia tátil e dolorosa discreta no território de V2 à direita, reflexo corneano presente, força mastigatória normal, restante do exame neurológico normal. O exame mais adequado a seguir é:

A) Nenhum, iniciar carbamazepina

B) RM de encéfalo com contraste

C) TC de crânio sem contraste

D) Radiografia panorâmica da mandíbula e maxila

---

18 Homem de 39 anos, de Teresina, com HIV em abandono de TARV (CD4 110 células/mm³), tem febre há 2 meses, emagrecimento de 9 kg e aumento do volume abdominal. Exame: baço a 12 cm e fígado a 4 cm do rebordo costal. Hb 7,6 g/dL, leucócitos 1.900/mm³, plaquetas 64.000/mm³, albumina 2,6 g/dL, gamaglobulina 4,1 g/dL, creatinina 1,0 mg/dL, QTc 440 ms. Aspirado de medula óssea com formas amastigotas de Leishmania. O tratamento e a conduta após a cura clínica são, respectivamente:

A) Anfotericina lipossomal / profilaxia secundária

B) Anfotericina lipossomal / sem profilaxia

C) Antimoniato de meglumina / profilaxia secundária

D) Antimoniato de meglumina / sem profilaxia

---

19 No bloqueio atrioventricular de segundo grau com condução 2:1, que não pode ser classificado em Mobitz I ou II pelo traçado de repouso, o achado que indica bloqueio abaixo do nó atrioventricular (infra-hissiano) é:

A) Piora da condução com esforço ou atropina

B) Melhora da condução com atropina

C) PR longo nos batimentos conduzidos

D) QRS estreito nos batimentos conduzidos

---

20 Mulher de 23 anos, com anemia falciforme (HbSS), será submetida a colecistectomia videolaparoscópica eletiva por colelitíase sintomática. Usa hidroxiureia 20 mg/kg/dia e ácido fólico. Teve duas internações por crise álgica no último ano, sem síndrome torácica aguda e sem AVC. Nunca foi transfundida e não tem anticorpos irregulares. Hb basal 7,6 g/dL, reticulócitos 9%, HbS 82% e HbF 12%. Exame físico sem alterações agudas, SpO2 97%. Quanto à preparação transfusional pré-operatória, a modalidade e o tipo de concentrado de hemácias são, respectivamente:

A) Exsanguineotransfusão / fenotipado para Rh e Kell

B) Exsanguineotransfusão / compatível apenas ABO e RhD

C) Transfusão simples até Hb 10 / fenotipado para Rh e Kell

D) Transfusão simples até Hb 10 / compatível apenas ABO e RhD

---

21 Agricultor de 42 anos é trazido 40 minutos após ingerir um inseticida organofosforado em tentativa de suicídio. Na chegada tinha sudorese profusa, vômitos, diarreia, miose puntiforme, fasciculações, broncorreia e sibilos, com FC de 52 bpm. Recebeu atropina em bolus com doses dobradas a cada 5 minutos, totalizando 14 mg, e pralidoxima foi iniciada. Agora: FC 122 bpm, PA 138 × 84 mmHg, pupilas ainda mióticas, axilas úmidas, estertores bolhosos bilaterais, SpO2 88% com máscara de reservatório, Glasgow 13. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Trocar a atropina por fisostigmina

B) Dobrar a dose de atropina

C) Suspender a atropina pela taquicardia

D) Intubar e suspender a atropina

---

22 Mulher de 34 anos tem diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos desde os 17 anos (ciclos irregulares, acne e hirsutismo leve) e usa anticoncepcional oral de forma irregular. Há 6 meses notou piora rápida dos pelos (escore de Ferriman-Gallwey de 24; era 9), engrossamento da voz, entradas na região temporal e aumento do clitóris; está sem menstruar há 4 meses. PA 122 × 78 mmHg, IMC 25 kg/m², sem estrias violáceas nem fraqueza proximal. Exames: beta-hCG negativo, testosterona total 248 ng/dL (VR até 45), DHEA-S 210 mcg/dL (VR 35 a 430), 17-OH-progesterona basal 110 ng/dL (VR até 200), prolactina e TSH normais. O próximo exame mais adequado é:

A) Teste de estímulo com ACTH

B) Ultrassonografia transvaginal

C) Tomografia de adrenais

D) Supressão com dexametasona 1 mg

---

23 Homem de 78 anos, com adenocarcinoma de próstata resistente à castração, metastático, em cuidados paliativos, PPS de 40% e expectativa de vida estimada em poucos meses, mora a 90 km do centro de radioterapia e depende da família para o transporte. Tem dor intensa em asa ilíaca direita há 3 semanas, apesar de morfina e dexametasona; a cintilografia mostra captação na asa ilíaca direita e em costelas, e a TC da pelve, lesão lítica-blástica sem fratura, sem risco iminente de fratura e sem extensão para partes moles ou canal medular. Para controle da dor, com o menor número de deslocamentos possível, a conduta mais adequada é:

A) Radiocirurgia estereotáxica em três frações

B) Fixação cirúrgica profilática do ilíaco

C) Radioterapia de 8 Gy em fração única

D) Radioterapia de 30 Gy em 10 frações

---

24 Homem de 52 anos vive com HIV há 7 anos, em uso de tenofovir desoproxila, lamivudina e dolutegravir desde o diagnóstico, com carga viral indetectável e CD4 de 640 células/mm³. É hipertenso, em uso de anlodipino, e não tem diabetes. Ao iniciar o dolutegravir, a creatinina passou de 0,9 para 1,05 mg/dL no primeiro mês e assim se manteve por anos. Há 6 meses tem dor óssea difusa e fraqueza para subir escadas, e usa ibuprofeno ocasionalmente. Hoje: creatinina 1,6 mg/dL, glicemia de jejum 92 mg/dL, HbA1c 5,4%, sódio 138 mEq/L, potássio 3,3 mEq/L, cloro 111 mEq/L, bicarbonato 18 mEq/L, fósforo 1,7 mg/dL, ácido úrico 2,0 mg/dL. EAS com glicose 2+, proteína 1+, sem hematúria e sem leucocitúria; relação proteína/creatinina urinária de 0,9 g/g, com relação albumina/creatinina de 60 mg/g. A causa mais provável da disfunção renal é:

A) Tubulopatia proximal pelo tenofovir

B) Bloqueio da secreção de creatinina pelo dolutegravir

C) Nefropatia associada ao HIV

D) Nefrite intersticial pelo ibuprofeno

---

25 Homem de 34 anos, tabagista desde os 15 anos, teve há 1 ano úlcera isquêmica no 3º pododáctilo esquerdo e episódios de cordão doloroso e avermelhado em veias superficiais da perna. Na época, FAN, ANCA, anticorpos antifosfolípides, crioglobulinas e sorologias para hepatites B e C foram negativos, o ecocardiograma transesofágico não mostrou trombos e a arteriografia revelou oclusões segmentares de artérias tibiais e digitais com colaterais em saca-rolhas, sem ateromatose proximal. Usa cilostazol e há 8 meses substituiu o cigarro pelo cigarro eletrônico, que usa ao longo do dia. Agora tem úlcera dolorosa na polpa do 2º quirodáctilo direito e frialdade da mão; pulso radial presente e ulnar ausente à direita. Glicemia e lípides normais. O fator que melhor explica a progressão é:

A) Embolia arterial de origem cardíaca

B) Aterosclerose precoce acelerada

C) Trombofilia hereditária não investigada

D) Exposição contínua à nicotina

---

26 Mulher de 33 anos, com HIV em TARV irregular (CD4 210 células/mm³), procura atendimento por visão turva, dor ocular leve e moscas volantes no olho direito há 10 dias. Exame: reação de câmara anterior discreta. Fundoscopia: lesão única branco-amarelada de retinocoroidite, de bordas pouco definidas, com 2 diâmetros de disco, adjacente a cicatriz hiperpigmentada antiga, e vitreíte intensa que turva a visualização; sem hemorragias retinianas. Olho esquerdo normal. Sorologias: toxoplasmose IgG reagente e IgM não reagente; VDRL não reagente. O diagnóstico mais provável é:

A) Sífilis ocular

B) Necrose retiniana aguda

C) Retinocoroidite por toxoplasma

D) Retinite por citomegalovírus

---

27 Homem de 52 anos, sem medicação, com PA de consultório de 146×92 mmHg e 144×90 mmHg em duas consultas, realiza MAPA de 24 horas válida, com média de 24 horas de 127×78 mmHg, média de vigília de 131×82 mmHg, média do sono de 124×74 mmHg e descenso noturno da sistólica de 5%. ECG com índice de Sokolow-Lyon de 37 mm e relação albumina/creatinina urinária de 42 mg/g. O diagnóstico é:

A) Hipertensão do avental branco

B) Hipertensão mascarada

C) Efeito do avental branco

D) Hipertensão sustentada

---

28 Homem de 44 anos, com hipertensão sem tratamento há anos, é trazido ao pronto-socorro com cefaleia progressiva há 2 dias, vômitos, visão turva e, hoje, confusão; teve uma crise tônico-clônica breve na chegada. PA 236/138 mmHg (repetida), FC 96 bpm. Sonolento, desorientado, sem déficit focal, sem rigidez de nuca. Fundo de olho: hemorragias em chama de vela, exsudatos algodonosos e edema de papila bilateral. Creatinina 1,9 mg/dL, urina com proteína 2+ e 10 hemácias por campo; troponina normal. TC de crânio: hipodensidade em substância branca parieto-occipital bilateral, sem sangramento. O anti-hipertensivo e a meta para a primeira hora são, respectivamente:

A) Nicardipina IV / PAS abaixo de 140 mmHg

B) Captopril sublingual / PAS abaixo de 140 mmHg

C) Captopril sublingual / queda da PAM de até 25%

D) Nicardipina IV / queda da PAM de até 25%

---

29 Mulher de 54 anos está internada há 10 dias por meningite pneumocócica, com cepa sensível. Recebeu dexametasona nos 4 primeiros dias e, desde a admissão, antibiótico betalactâmico endovenoso de 12 em 12 horas, com boa evolução neurológica. Hoje, 30 minutos após a dose da manhã, apresenta calafrios, dor lombar e urina cor de coca. Hb 6,9 g/dL (11,8 g/dL há 2 dias), reticulócitos 6%, LDH 2.100 U/L, bilirrubina indireta 3,8 mg/dL, haptoglobina indetectável, esferócitos no esfregaço, Coombs direto positivo para IgG e C3d. Plaquetas e creatinina normais. Nunca foi transfundida e não tem doença autoimune conhecida. A conduta mais adequada é:

A) Rituximabe e manter o antibiótico

B) Prednisona 1 mg/kg e manter o antibiótico

C) Suspender e trocar o antibiótico

D) Plasmaférese de urgência

---

30 Mulher de 27 anos, com retocolite ulcerativa extensa há 3 anos, em uso irregular de mesalazina, foi internada com 10 evacuações com sangue ao dia, FC 108 bpm e Tax 37,9 °C, e iniciou hidrocortisona 100 mg IV de 8 em 8 horas. Pesquisa de toxina de Clostridioides difficile negativa e biópsias da retossigmoidoscopia sem inclusões de citomegalovírus. Hoje, no terceiro dia de hidrocortisona: 8 evacuações com sangue nas últimas 24 horas, PCR 5,8 mg/dL, abdome flácido, radiografia simples sem dilatação colônica. Exames: Hb 9,8 g/dL, albumina 2,7 g/dL, magnésio 1,4 mg/dL, colesterol total 88 mg/dL, creatinina 0,7 mg/dL. Rastreio de tuberculose e hepatite B negativo. Quanto à terapia de resgate e ao momento, respectivamente:

A) Infliximabe / agora, no terceiro dia

B) Ciclosporina / agora, no terceiro dia

C) Infliximabe / após sete dias de corticoide

D) Ciclosporina / após sete dias de corticoide

---

31 Homem de 39 anos, etilista pesado, com dentes em péssimo estado, teve um episódio de embriaguez com vômitos há 3 semanas. Desde então tem febre baixa, tosse com escarro fétido e perda de 3 kg. Nunca fumou. Teste rápido molecular para tuberculose no escarro, em duas amostras: negativo. Anti-HIV negativo. SpO2 95%, PA 126 × 80 mmHg, aceitando dieta. Leucócitos 15.600/mm³. TC: cavidade de 5 cm de paredes espessas, com nível hidroaéreo, no segmento posterior do lobo superior direito, sem massa endobrônquica, sem linfonodomegalia e sem empiema. A conduta mais adequada é:

A) Amoxicilina-clavulanato por semanas

B) Drenagem percutânea guiada por TC

C) Broncoscopia antes do antibiótico

D) Esquema básico para tuberculose

---

32 Mulher de 27 anos, primigesta com 9 semanas, está internada por hiperêmese gravídica: vomita várias vezes ao dia há 2 semanas e perdeu 4 kg. Refere palpitações leves. Nunca teve doença tireoidiana. Exame: FC 104 bpm, PA 110 × 70 mmHg, mucosas secas, tireoide de volume normal e sem sopro, sem exoftalmia, sem tremor de extremidades. Exames: TSH abaixo de 0,01 mUI/L, T4 livre 2,3 ng/dL (VR 0,9 a 1,8), T3 total 190 ng/dL, TRAb negativo, beta-hCG 182.000 mUI/mL, potássio 3,2 mEq/L, cetonúria 3+. Ultrassonografia obstétrica: gestação única tópica, compatível com a idade gestacional. A conduta mais adequada em relação à tireoide é:

A) Metimazol em dose baixa

B) Tireoidectomia no segundo trimestre

C) Propiltiouracil em dose baixa

D) Suporte e repetir a função tireoidiana

---

33 Homem de 24 anos recebe alta após o segundo episódio de meningite em 3 anos, ambos com Neisseria meningitidis sorogrupo Y isolada no líquor, com boa evolução. Um primo materno morreu de meningococcemia aos 17 anos. Nega trauma craniano, cirurgia prévia ou rinorreia. Recebeu vacina meningocócica C na adolescência. Nunca teve pneumonias, sinusites ou otites de repetição. Hemograma, imunoglobulinas séricas e anti-HIV normais. TC de crânio sem alterações. O próximo exame mais adequado é:

A) TC de alta resolução da base do crânio

B) Teste da di-hidrorodamina em neutrófilos

C) Atividade hemolítica do complemento (CH50 e AH50)

D) Subpopulações de linfócitos T

---

34 Mulher de 41 anos é encaminhada por cálcio total entre 10,7 e 11,0 mg/dL (VR 8,6 a 10,2 mg/dL), com albumina normal, em cinco dosagens nos últimos 6 anos. É assintomática, nunca teve cólica renal nem fratura, e a densitometria é normal. Não usa tiazídico, lítio nem suplementos de cálcio ou vitamina D. Exames: PTH 72 pg/mL (VR 15 a 65 pg/mL), fósforo 2,6 mg/dL, magnésio 2,5 mg/dL (VR 1,7 a 2,4 mg/dL), creatinina 0,7 mg/dL, 25-hidroxivitamina D de 34 ng/mL. Ultrassonografia de rins sem cálculos. O cirurgião de cabeça e pescoço lembra que a idade abaixo de 50 anos, por si, já indica paratireoidectomia no hiperparatireoidismo primário. O exame mais adequado a seguir é:

A) Ultrassonografia de paratireoides

B) Calciúria de 24 horas com creatininúria

C) Cintilografia com sestamibi

D) Sequenciamento do gene CASR

---

35 Mulher de 29 anos voltou há 10 dias de 1 mês de trabalho voluntário em Bangladesh. Há 12 dias tem febre progressiva, hoje de 39,4 °C, cefaleia, dor abdominal difusa e constipação. Antes de voltar, tomou por conta própria ciprofloxacino por 5 dias, sem melhora. Exame: FC 84 bpm com T 39,4 °C, máculas róseas esparsas no abdome, hepatoesplenomegalia discreta. Leucócitos 3.600/mm³, sem eosinófilos, plaquetas 118.000/mm³; ALT 120 U/L. Três gotas espessas e teste rápido para malária negativos; NS1 e IgM para dengue não reagentes. Duas amostras de hemoculturas colhidas na admissão estão negativas após 5 dias. Para confirmar a hipótese principal, o próximo exame mais adequado é:

A) Reação de Widal

B) Repetir hemoculturas

C) Mielocultura

D) Coprocultura

---

36 Mulher de 34 anos, com doença celíaca diagnosticada há 2 anos (antitransglutaminase IgA 20 vezes o limite superior e biópsia duodenal Marsh 3c), mantém distensão, 3 a 4 evacuações amolecidas ao dia e anemia ferropriva leve. Afirma seguir rigorosamente a dieta sem glúten: lê os rótulos, mas almoça diariamente no restaurante do trabalho e usa a mesma torradeira da família. Nega anti-inflamatórios e outras medicações. Exame físico normal; IMC 21 kg/m². Exames: Hb 11,4 g/dL, ferritina 14 ng/mL, albumina 4,0 g/dL, antitransglutaminase IgA 8 vezes o limite superior, IgA total normal, TSH normal. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Nova endoscopia com biópsias duodenais

B) Budesonida de liberação ileal

C) Cápsula endoscópica do delgado

D) Revisão dietética com nutricionista

---

37 Homem de 44 anos, com transplante renal de doador falecido há 14 meses, usa tacrolimo, micofenolato e prednisona 5 mg/dia, com creatinina estável de 1,2 mg/dL. Usa anlodipino 10 mg/dia, com PA de 132/82 mmHg. Queixa-se de cefaleia leve. Hb 17,9 g/dL e Ht 54% (13,5 g/dL no 3º mês após o transplante), leucócitos e plaquetas normais, sem esplenomegalia. Não fuma, SpO2 98% em ar ambiente, polissonografia normal. Eritropoetina sérica 14 mU/mL (VR 4 a 24), JAK2 V617F negativo. Ultrassonografia: enxerto sem lesões e rins nativos com cistos simples pequenos. A conduta inicial mais adequada é:

A) Iniciar hidroxiureia

B) Suspender o tacrolimo

C) Flebotomias seriadas isoladas

D) Trocar anlodipino por IECA

---

38 Homem de 54 anos, previamente hígido, está no 16º dia de UTI por pneumonia grave com SDRA e choque séptico. Recebeu cisatracúrio contínuo por 72 horas (suspenso no 5º dia) e hidrocortisona 200 mg/dia por 7 dias. Sedação suspensa há 5 dias: está desperto, obedece a comandos com a face, mas falha no teste de respiração espontânea e tem tetraparesia flácida simétrica, proximal mais que distal, com reflexos diminuídos; faz careta e retira os quatro membros ao estímulo doloroso e percebe o diapasão nos háluces. CPK 1.140 U/L (VR até 190). Eletroneuromiografia: potenciais de ação motores de amplitude reduzida e duração aumentada, potenciais sensitivos de amplitude normal, sem bloqueio de condução e sem decremento à estimulação repetitiva. O diagnóstico mais provável é:

A) Síndrome de Guillain-Barré

B) Bloqueio neuromuscular residual

C) Miopatia do doente crítico

D) Polineuropatia do doente crítico

---

39 Mulher de 74 anos, hipertensa, em uso de naproxeno por artrose há 2 meses, é admitida com melena há 2 dias e tontura ao levantar. Nega dor torácica, dispneia ou palpitações em toda a evolução. PA 92×58 mmHg, FC 118 bpm. Hemoglobina de 6,4 g/dL (12,8 g/dL há 3 meses). ECG: taquicardia sinusal com infradesnivelamento horizontal do segmento ST de 1,5 mm de V4 a V6, ausente em traçado anterior. Troponina T ultrassensível de 64 ng/L na admissão e de 118 ng/L após 3 horas (referência até 14). Ecocardiograma sem alteração da contratilidade segmentar, fração de ejeção de 62%. O diagnóstico mais provável é:

A) Angina instável de alto risco

B) Injúria miocárdica aguda não isquêmica

C) Infarto agudo do miocárdio tipo 2

D) Infarto agudo do miocárdio tipo 1

---

40 Homem de 34 anos, com diabetes tipo 1, usa insulina NPH 18 unidades antes do café e 14 unidades antes do jantar (às 19 horas), além de insulina regular antes das refeições. Há 1 mês, por glicemias de jejum em torno de 190 mg/dL, a NPH do jantar foi aumentada de 10 para 14 unidades; desde então, as glicemias de jejum pioraram para 230 a 260 mg/dL. Acorda com cefaleia, roupa de cama molhada de suor e pesadelos frequentes. A pedido do médico, mediu a glicemia capilar às 3 horas em três noites: 48, 52 e 55 mg/dL. HbA1c de 7,6%. O fenômeno responsável e a conduta mais adequada são, respectivamente:

A) Hipoglicemia com rebote / reduzir e adiar a NPH

B) Hipoglicemia com rebote / aumentar a NPH do jantar

C) Fenômeno do alvorecer / reduzir e adiar a NPH

D) Fenômeno do alvorecer / aumentar a NPH do jantar

---

41 Mulher de 68 anos, magra (IMC 19 kg/m²), nunca fumou, tem tosse produtiva crônica há 2 anos, sem febre, hemoptise ou perda de peso recente. TC de tórax: bronquiectasias cilíndricas no lobo médio e na língula, com nódulos centrolobulares em árvore em brotamento, sem cavitação. Anti-HIV negativo. Duas baciloscopias e um teste rápido molecular para tuberculose no escarro foram negativos; na cultura de uma das amostras cresceu complexo Mycobacterium avium, e a cultura da outra amostra foi negativa. Ela está bem e pergunta se vai precisar tomar remédios. A conduta mais adequada agora é:

A) Claritromicina, rifampicina e etambutol

B) Esquema básico para tuberculose

C) Nova coleta de escarro para cultura

D) Broncoscopia com biópsia transbrônquica

---

42 Homem de 27 anos procura a emergência por lesões cutâneas há 3 dias. Há 10 dias teve vesículas dolorosas no lábio superior, como já ocorrera outras vezes, e há 4 dias tomou dipirona por cefaleia. Exame: Tax 37,6 °C; lesões em alvo arredondadas, com três zonas concêntricas e centro escuro, algumas com bolha central, simétricas no dorso das mãos, nas palmas, nos antebraços, nos cotovelos e nos joelhos, com poucas lesões no tronco; erosões na mucosa labial e jugal. Nikolsky negativo e sem áreas de destacamento epidérmico. Hemograma e provas hepáticas normais. Não usa outros medicamentos. A etiologia mais provável é:

A) Eritema multiforme maior pelo herpes simples

B) Síndrome de Stevens-Johnson pela dipirona

C) Erupção fixa bolhosa generalizada pela dipirona

D) Pênfigo paraneoplásico

---

43 Homem de 71 anos, hipertenso e ex-tabagista, teve herpes-zóster oftálmico à esquerda há 7 semanas, tratado com valaciclovir por 7 dias. Há 2 semanas teve dois episódios de afasia e fraqueza da mão direita, de 30 minutos cada, e hoje acordou com hemiparesia direita leve. PA 146 × 88 mmHg, ritmo regular, T 36,9 °C. RM de crânio: infartos pequenos em núcleo caudado e cápsula interna à esquerda, de idades diferentes. Angiorressonância: estreitamento segmentar e focal do segmento proximal da artéria cerebral média esquerda; carótidas sem placas significativas. ECG e Holter de 24 horas em ritmo sinusal; ecocardiograma transtorácico normal. VHS 16 mm/h, PCR 0,4 mg/dL. Líquor: 14 células/mm³ (95% linfócitos), proteína 62 mg/dL, glicose 60 mg/dL (glicemia 98 mg/dL); PCR para VZV no líquor não detectado. O diagnóstico mais provável é:

A) Aterosclerose intracraniana

B) Arterite de células gigantes

C) Embolia de origem cardíaca

D) Vasculopatia pelo VZV

---

44 Mulher de 39 anos, sem comorbidades, não usa contraceptivo hormonal, procura o pronto-socorro por dor abdominal difusa há 6 dias. A angiotomografia mostra trombose aguda do tronco da veia porta e do ramo direito, sem sinais de cirrose, sem neoplasia, sem pancreatite ou foco infeccioso abdominal, e baço de 13,5 cm. Iniciou enoxaparina. Exames: Hb 13,9 g/dL, hematócrito 42%, leucócitos 8.400/mm³, plaquetas 318.000/mm³, LDH, bilirrubina indireta e reticulócitos normais, função hepática normal. A investigação etiológica está em curso, e o primeiro exame pedido deve ser o de maior rendimento. O próximo exame mais adequado é:

A) Dosagem de antitrombina e proteínas C e S

B) Pesquisa da mutação JAK2 V617F

C) Pesquisa de fator V de Leiden

D) Citometria de fluxo para hemoglobinúria paroxística noturna

---

45 Homem de 74 anos, com diabetes tipo 2, é admitido sonolento após 5 dias de poliúria. PA 88/54 mmHg, FC 120 bpm. Exames iniciais: glicose 1.050 mg/dL, sódio 136 mEq/L, potássio 4,8 mEq/L, bicarbonato 21 mEq/L, cetonemia negativa, ureia 120 mg/dL, creatinina 2,2 mg/dL. Recebeu 2 L de SF 0,9% na primeira hora e mais 1 L na segunda; agora PA 124/76 mmHg, FC 96 bpm, diurese de 100 mL/h, potássio 4,4 mEq/L, e a insulina contínua foi iniciada. Na quarta hora: glicose 620 mg/dL e sódio 146 mEq/L. O fluido mais adequado a seguir é:

A) Manter SF 0,9% a 500 mL/h

B) Trocar para salina a 0,45%

C) Glicosado a 5% com salina a 0,45%

D) Bicarbonato de sódio isotônico

---

46 Mulher de 26 anos, no 3º dia após cesariana, apresenta hematoma volumoso na ferida operatória, embora a hemostasia tenha sido adequada no ato cirúrgico. Refere que, após extrações dentárias, o sangramento recomeçava 1 a 2 dias depois; tem equimoses extensas com pequenos traumas e dois abortamentos espontâneos no primeiro trimestre. A mãe conta que ela sangrou pelo coto umbilical na primeira semana de vida. Exames: plaquetas 245.000/mm³, TP, TTPa e tempo de trombina normais, fibrinogênio 320 mg/dL, fator de von Willebrand (antígeno e atividade) e fator VIII normais, agregação plaquetária normal. O diagnóstico mais provável é:

A) Doença de von Willebrand tipo 1

B) Deficiência de fator XII

C) Disfibrinogenemia

D) Deficiência de fator XIII

---

47 Homem de 58 anos, com lombalgia crônica, perdeu 14 kg em 3 meses após cirurgia bariátrica e passou a trabalhar horas de pernas cruzadas. Há 10 dias acordou com o pé direito 'caindo', tropeça e tem dormência no dorso do pé. Exame: dorsiflexão do pé e extensão do hálux direitos grau 2, eversão grau 2; inversão do pé grau 5 e flexão plantar grau 5; abdução do quadril normal; reflexos patelar e aquileu presentes e simétricos; hipoestesia no dorso do pé e na face lateral da perna distal; Lasègue negativo; Tinel positivo na cabeça da fíbula direita. RM lombar de 1 ano atrás: protrusão discal L4-L5 com contato na raiz L5 direita. A localização mais provável da lesão é:

A) Fibular comum no colo da fíbula

B) Raiz L5 direita no recesso lateral

C) Tronco lombossacral na pelve

D) Isquiático na região da coxa

---

48 Mulher de 33 anos, com lúpus eritematoso sistêmico há 8 anos e dois abortamentos espontâneos de primeiro trimestre, é internada por afasia e hemiparesia direita que regrediram parcialmente em 24 horas. Sem febre em nenhum momento; nega uso de drogas intravenosas e não tem neoplasia conhecida. Ressonância: infartos corticais múltiplos em territórios distintos. Exame: PA 128×80 mmHg, FC 82 bpm, sopro holossistólico 2+/6+ no ápice, irradiado para a axila. Leucócitos 4.100/mm³, PCR 0,8 mg/dL; três pares de hemoculturas negativos, colhidos antes de qualquer antibiótico; sorologias para Coxiella e Bartonella negativas. Anticoagulante lúpico positivo e anticardiolipina IgG em título alto, confirmados após 12 semanas. Ecocardiograma transesofágico: vegetações sésseis e verrucosas na face atrial dos dois folhetos mitrais, com insuficiência mitral moderada, sem abscesso. A lesão valvar e a prevenção secundária são, respectivamente:

A) Endocardite marântica / rivaroxabana

B) Libman-Sacks / rivaroxabana

C) Endocardite marântica / varfarina

D) Libman-Sacks / varfarina

---

49 Mulher de 58 anos tem granulomatose com poliangeíte em remissão há 2 anos. Recebeu indução com rituximabe e manutenção com rituximabe 500 mg a cada 6 meses, suspensa há 9 meses pela remissão sustentada. No último ano teve três pneumonias com internação, uma delas com bacteremia pneumocócica, e duas sinusites bacterianas. Usa sulfametoxazol-trimetoprima profilático e recebeu vacina pneumocócica conjugada há 6 meses. Está sem infecção ativa. Exames: IgG 290 mg/dL (VR 700 a 1.600), IgA 40 mg/dL, IgM 18 mg/dL, albumina 4,1 g/dL, proteinúria ausente, linfócitos B CD19 de 0,5%; resposta de anticorpos à vacina pneumocócica ausente. A conduta mais adequada é:

A) Azitromicina profilática três vezes por semana

B) Reposição periódica de imunoglobulina humana

C) Revacinar com a pneumocócica 23-valente

D) Observar e repetir a IgG em 6 meses

---

50 Homem de 68 anos, hipertenso em uso de anlodipino há 6 anos, procura atendimento por prurido intenso e icterícia há 10 dias, com colúria e fezes claras. Há 5 semanas tratou sinusite com um antibiótico em comprimidos de 875/125 mg, de 12 em 12 horas, por 10 dias, terminado há 3 semanas, sem sintomas na ocasião. Nega álcool, chás e suplementos. Exame: icterícia 3+/4+, escoriações, sem febre, sem dor abdominal, vesícula não palpável. Exames: bilirrubina total 7,4 mg/dL (direta 6,1), fosfatase alcalina 520 U/L (referência até 120), GGT 610 U/L, ALT 180 U/L (referência até 40), INR 1,1. Anti-HAV IgM, HBsAg, anti-HBc IgM e anti-HCV não reagentes; antimitocôndria negativo. Ultrassonografia e colangiorressonância: vias biliares sem dilatação, sem cálculos ou massas, pâncreas normal. A etiologia mais provável é:

A) Colangite biliar primária

B) Coledocolitíase com cálculo já eliminado

C) Lesão hepática por amoxicilina-clavulanato

D) Colangiocarcinoma hilar

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado 9

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1 (A) (B) (C) (D)	2 (A) (B) (C) (D)	3 (A) (B) (C) (D)	4 (A) (B) (C) (D)
5 (A) (B) (C) (D)	6 (A) (B) (C) (D)	7 (A) (B) (C) (D)	8 (A) (B) (C) (D)
9 (A) (B) (C) (D)	10 (A) (B) (C) (D)	11 (A) (B) (C) (D)	12 (A) (B) (C) (D)
13 (A) (B) (C) (D)	14 (A) (B) (C) (D)	15 (A) (B) (C) (D)	16 (A) (B) (C) (D)
17 (A) (B) (C) (D)	18 (A) (B) (C) (D)	19 (A) (B) (C) (D)	20 (A) (B) (C) (D)
21 (A) (B) (C) (D)	22 (A) (B) (C) (D)	23 (A) (B) (C) (D)	24 (A) (B) (C) (D)
25 (A) (B) (C) (D)	26 (A) (B) (C) (D)	27 (A) (B) (C) (D)	28 (A) (B) (C) (D)
29 (A) (B) (C) (D)	30 (A) (B) (C) (D)	31 (A) (B) (C) (D)	32 (A) (B) (C) (D)
33 (A) (B) (C) (D)	34 (A) (B) (C) (D)	35 (A) (B) (C) (D)	36 (A) (B) (C) (D)
37 (A) (B) (C) (D)	38 (A) (B) (C) (D)	39 (A) (B) (C) (D)	40 (A) (B) (C) (D)
41 (A) (B) (C) (D)	42 (A) (B) (C) (D)	43 (A) (B) (C) (D)	44 (A) (B) (C) (D)
45 (A) (B) (C) (D)	46 (A) (B) (C) (D)	47 (A) (B) (C) (D)	48 (A) (B) (C) (D)
49 (A) (B) (C) (D)	50 (A) (B) (C) (D)		